

Invecchiamento

Pensate a una persona anziana.

Pensate a una o due caratteristiche che la definiscono.

- A quale categoria appartengono queste caratteristiche?
- Corpo / fisico
- Cervello / cognizione
- Psiche / benessere mentale
- Socio-relazionale-economica
- Clinica / malattie
- Altro

Oggi: che cosa dovrete saper fare?

1. Guardare la persona attraverso il modello bio-psico-sociale

- Riconoscere gli aspetti biologici, psicologici e sociali di una situazione
- Spiegare come queste componenti possono influenzarsi reciprocamente

2. Comprendere e utilizzare il concetto di fragilità

- Spiegare la fragilità come vulnerabilità agli stressor
- Riconoscere che esistono diversi modelli operativi e scegliere lo strumento in base allo scopo
- Comprendere perché la fragilità può segnalare bisogni di salute complessi

Invecchiamento

L'età è solo una parte...

L'età cronologica rimane

- uno dei principali fattori di rischio non modificabili per malattia e morte

MA

- è uguale per tutti
- non differenzia i bisogni

Il modello

La lente utilizzata per guardare l'invecchiamento è il modello

bio-psico-sociale

Biologico

- Cellule, tessuti e organi cambiano con il tempo
- Il danno può accumularsi e favorire malattia
- La malattia può contribuire a perdita di funzione e disabilità

Psicologico

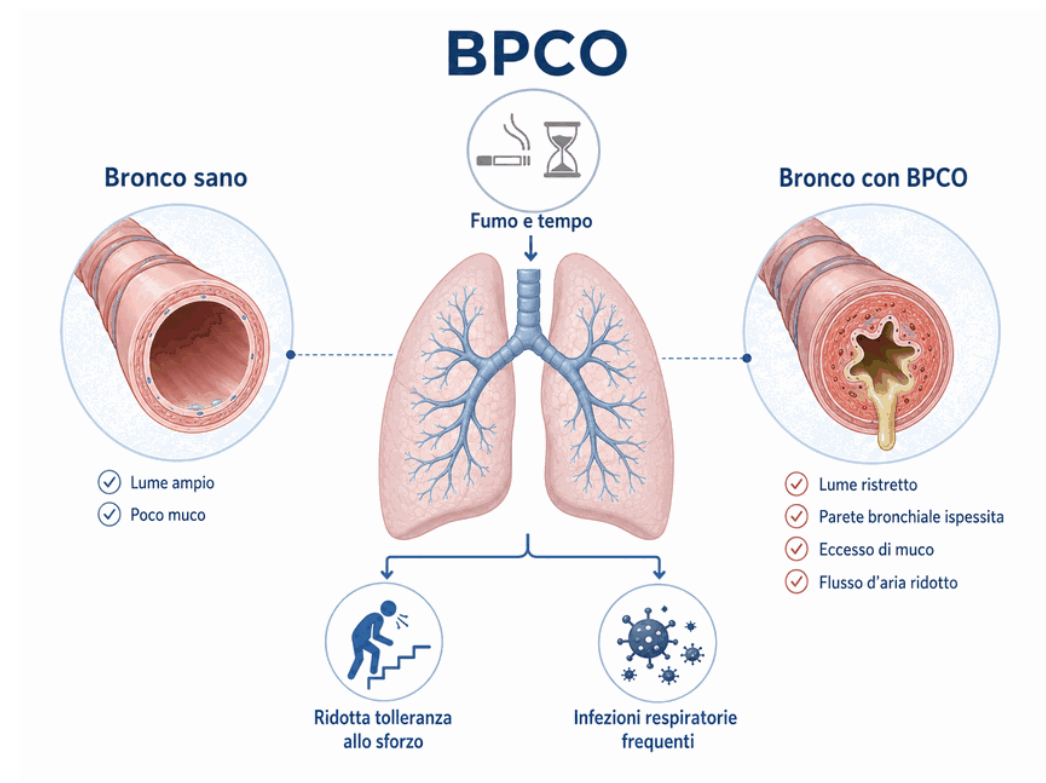
- L'invecchiamento modifica la percezione di sé e del mondo
- La percezione di sé e del mondo può modificare il modo di invecchiare

Sociale

- L'invecchiamento modifica famiglia, lavoro, relazioni e società
- Ambiente e società influenzano a loro volta il modo di invecchiare

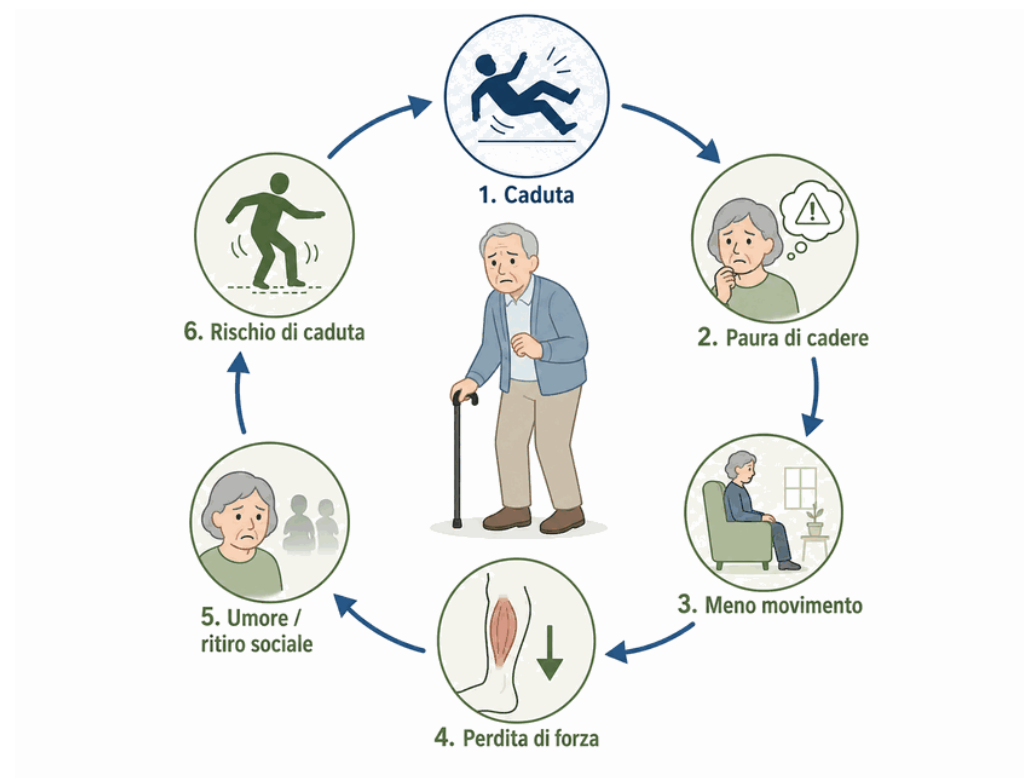
Visione biologica

- Il tempo e il fumo danneggiano vie aeree e tessuto polmonare
- Si sviluppano infiammazione cronica, alterazione delle secrezioni e rimodellamento
- Il flusso dell'aria diventa progressivamente più ostacolato
- Si instaura la **broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)**
- Una persona con BPCO può avere **dispnea e ridotta tolleranza allo sforzo**
- Può inoltre sviluppare **riacutizzazioni** e complicanze respiratorie



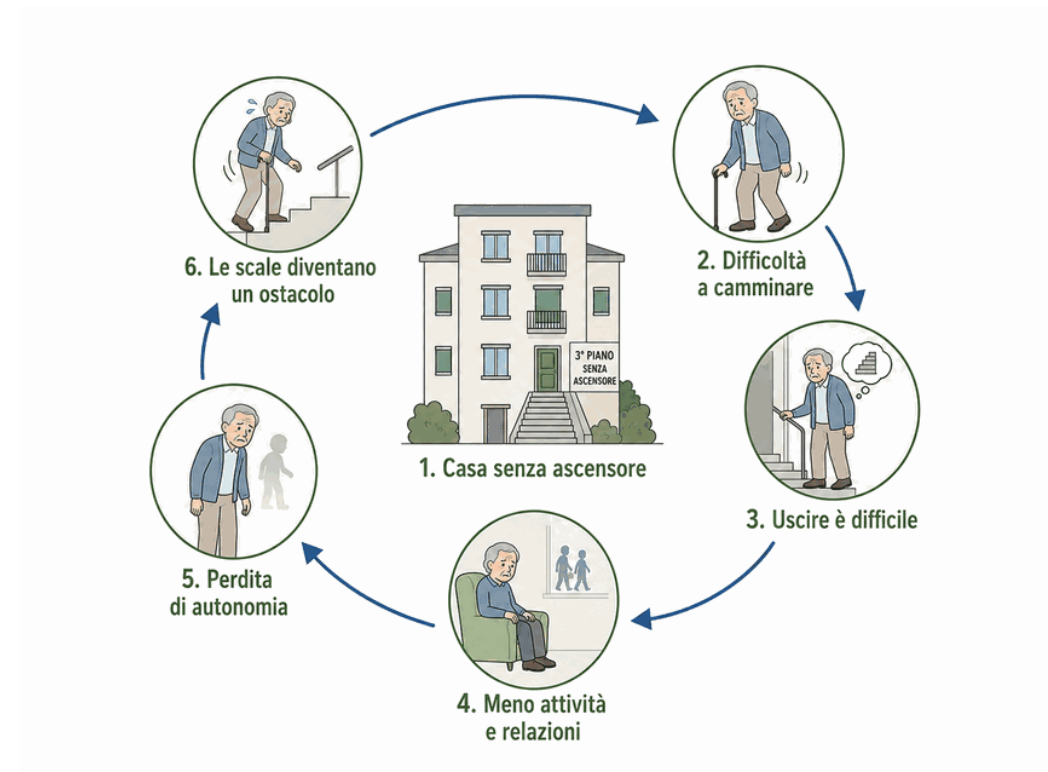
Visione psicologica

- Una persona che cade può sviluppare **paura di cadere**
- Per paura di cadere si muove meno
- La minore attività favorisce **perdita di forza**
- Possono comparire **riduzione del tono dell'umore** e ritiro sociale
- La persona si muove ancora meno
- **Il rischio di una nuova caduta aumenta**



Visione sociale

- Una persona anziana vive al **terzo piano senza ascensore**
- Se cammina con difficoltà, **uscire di casa diventa difficile**
- Si riducono **movimento, attività e relazioni**
- Aumentano **dipendenza** e perdita di autonomia
- Le scale diventano un ostacolo sempre maggiore



Attività — Il caso di Anna

Anna, 79 anni, vive con il marito, che ha bisogno di aiuto nelle attività quotidiane.

Da alcuni anni Anna ha uno **scompenso cardiaco**: il suo cuore fatica a sostenere la circolazione del sangue. Negli ultimi mesi avverte **stanchezza e mancanza di fiato** anche quando fa la spesa o rifà il letto.

Per **paura di sentirsi male fuori casa**, esce sempre meno e ha smesso di incontrare le amiche con cui trascorreva i pomeriggi.

Il marito si preoccupa quando Anna è affaticata e cerca di aiutarla, ma anche lui ha difficoltà nelle attività domestiche. Anna **si sente in colpa** perché non riesce più ad aiutarlo come prima.

Da qualche tempo Anna **si sente triste** e ha perso interesse per molte delle sue attività abituali.

Attività — Che cosa sta succedendo?

Rileggi il caso di Anna.

Identifica almeno un elemento per ciascuna dimensione

- **Biologica:** quali problemi riguardano il corpo e le sue funzioni?
- **Psicologica:** quali elementi riguardano emozioni, pensieri e percezione di sé?
- **Sociale:** quali elementi riguardano relazioni, ruoli e vita quotidiana?

Attività — Costruiamo la rete

In gruppo

1. **Collegate** con delle frecce gli elementi che possono influenzarsi.
2. **Spiegate** per ogni freccia come un elemento può influenzare l'altro.
3. **Cercate un circolo:** una conseguenza può tornare a influenzare il problema iniziale?

Domanda guida: come può un problema biologico influenzare la vita psicologica e sociale di Anna? E come possono queste dimensioni influenzare nuovamente il suo benessere fisico?

Il modello bio-psico-sociale — da ricordare

La **salute della persona** è il risultato dell'interazione tra fattori **biologici, psicologici e sociali**.

- Uno stesso problema di salute può avere componenti in **tutte e tre le dimensioni**
- Queste componenti **non sono indipendenti**: possono influenzarsi reciprocamente, anche formando circoli
- Per comprendere il problema e prendersi cura della persona dobbiamo considerare **anche le interazioni**, non soltanto la malattia

PAUSA

10 minuti...

La fragilità

Osservazione empirica

Alcune persone hanno conseguenze molto più gravi di altre davanti allo **stesso evento stressante**.

La fragilità

Uno stesso stressor: un'infezione

Persona robusta

- Modesto impatto funzionale
- Buona tolleranza allo stressor
- Recupero relativamente rapido
- Ritorno alle attività abituali

Persona fragile

- Importante perdita funzionale
- Maggiore rischio di complicanze
- Possibile delirium o immobilità
- Recupero più lento o incompleto

La fragilità

Uno stato di aumentata vulnerabilità agli stressor, legato alla riduzione delle riserve e della capacità di mantenere o recuperare l'omeostasi

- Uno stressor può produrre conseguenze sproporzionate
- Il rischio di complicanze, eventi avversi e outcome negativi aumenta

I problemi

1. **Standardizzare** la misura e la definizione nella pratica
2. Evitare che la fragilità diventi un **criterio automatico di esclusione**

Standardizzare la misura

La fragilità descrive un *rischio*.

Come possiamo misurarla?

- Sono stati proposti numerosissimi strumenti
- Al di là dello strumento:
- è importante conoscere **popolazione e validazione**
- è importante soprattutto *pensare* alla fragilità

Frailty Index

Intuizione:

- considero numerosi *problemi di salute* (= **deficit**)
- attribuisco a ciascun deficit un valore tra **0 e 1**
- sommo il danno accumulato
- standardizzo sul numero di deficit considerati

FI = deficit accumulati / deficit valutati

Frailty Index — esempio

[Apri lo strumento online](#)

Fenotipo di fragilità

Modello teorico:

Quali sono le caratteristiche *manifeste* della fragilità?



Clinical Frailty Scale (CFS)

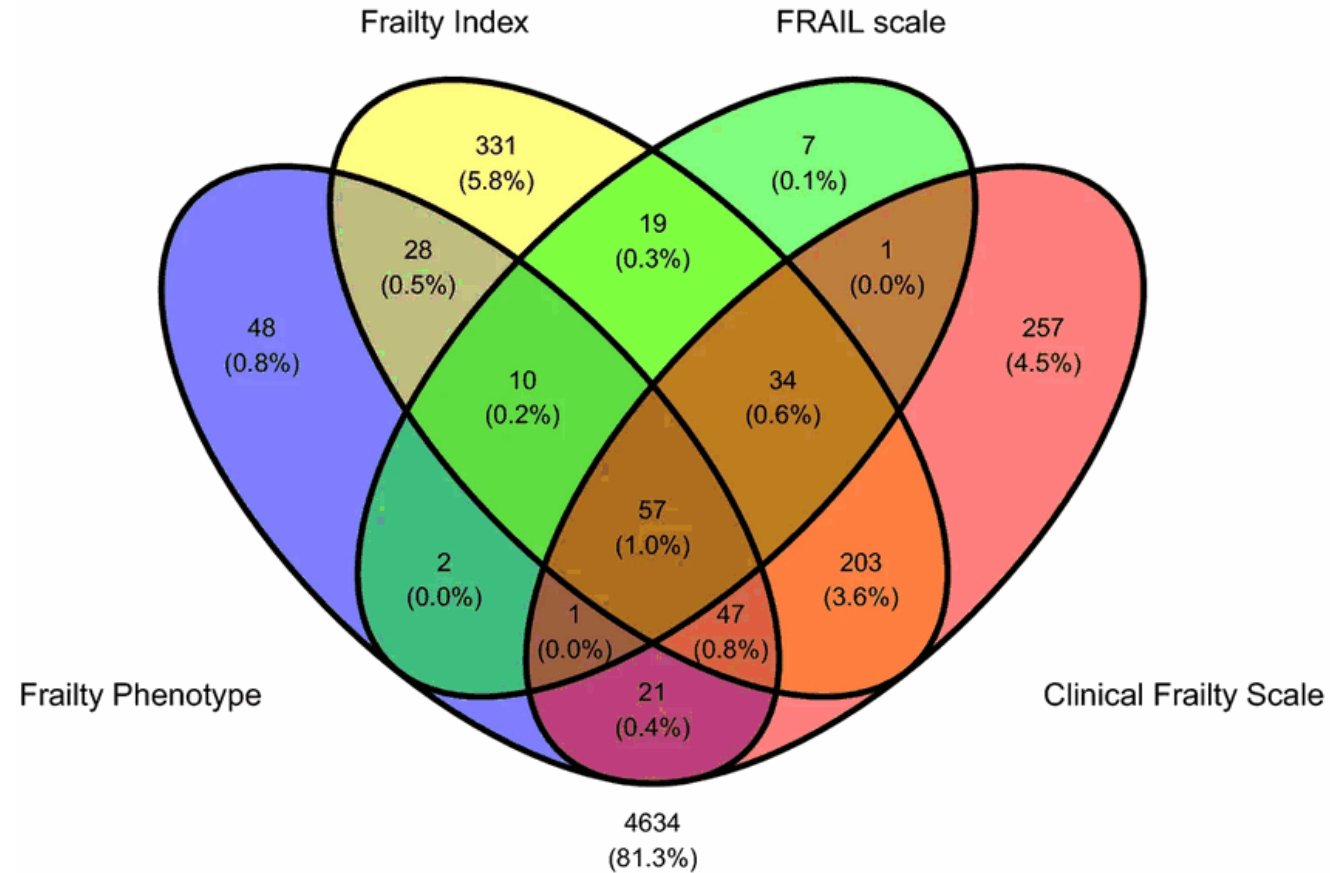
Applicazione pratica

Fragilità clinica: una scala pratica

1 	Molto in forma attivo, energico, completamente autonomo
2 	In forma autonomo, senza limitazioni rilevanti
3 	Gestione autonoma malattie presenti ma vita indipendente
4 	Vulnerabile rallentato, stanco, ancora indipendente
5 	Lieve fragilità aiuto nelle attività complesse (spesa, farmaci, finanze)
6 	Fragilità moderata bisogno di aiuto fuori casa e in alcune attività quotidiane
7 	Fragilità marcata dipendenza per la maggior parte delle attività personali
8 	Fragilità molto severa dipendenza quasi completa, mobilità molto ridotta
9 	Fine vita malattia avanzata, aspettativa di vita limitata
? Domanda chiave: come vive abitualmente la persona?  mobilità  autonomia  attività quotidiane  bisogno di aiuto	

Dicono la stessa cosa?

From: Frail by different measures: a comparison of 8-year mortality in The Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA)



Venn diagram representing the overlap between the four frailty classifications in the first wave of TILDA (population aged 50 and over, N = 5700). Number and percentages of TILDA wave 1 participants are shown. 4634 participants were not classified as frail by any scheme

Una fragilità, diverse prospettive

- **Frailty Index:** fragilità rappresentata come **accumulo di deficit** di salute
- **Fenotipo di Fried:** fragilità rappresentata attraverso **cinque manifestazioni fisiche**
- **Clinical Frailty Scale:** **valutazione clinica globale**, che considera anche funzione e dipendenza

Sono modi diversi di rappresentare e valutare la fragilità: non sono necessariamente intercambiabili.

Attività

Considerate i tre strumenti per valutare la fragilità:

- **FI** — accumulo di deficit
- **FP** — cinque criteri fenotipici
- **CFS** — giudizio clinico gerarchico su funzione e dipendenza

In gruppo, ordinate i tre strumenti in base a:

- Facilità di utilizzo in una struttura **residenziale**
- **Obiettività**
- Facilità di comunicare il risultato al **caregiver**

Per ogni graduatoria, motivate almeno la prima e l'ultima posizione.

Domanda finale: usereste necessariamente lo stesso strumento in una ricerca e in una visita in struttura residenziale? Perché?

Qual è il modello giusto?

Non esiste un unico modello operativo che rappresenti in modo **completo e definitivo** la fragilità.

Scegliamo lo strumento in base alla domanda

- **Che cosa** vogliamo conoscere?
- In quale **popolazione e contesto** lo utilizzeremo?
- **Per quale scopo** useremo il risultato?

Il modello è uno strumento per rispondere a una domanda, non la realtà stessa.

Escludere sulla base della fragilità

Molti strumenti di fragilità hanno dimostrato **capacità prognostica**.

Questo significa che:

1. è importante riconoscere la fragilità, non soltanto scegliere una specifica scala
2. una persona più fragile presenta mediamente un rischio maggiore di eventi avversi e morte

Predire il rischio non significa decidere automaticamente il trattamento.

Esempio

Una persona di 78 anni, **CFS 7**, ha una neoplasia.

È disponibile un trattamento oncologico con possibili benefici, ma anche con importanti effetti avversi.

L'oncologo decide di non proporlo **sulla sola base della fragilità**.

Qual è il problema di questo approccio?

La cura centrata sulla persona

Può essere condivisibile non iniziare uno specifico trattamento, ma rimangono molte possibilità:

- proporre un approccio simultaneo-palliativo
- proporre supporto psicologico
- educare sulla possibile evoluzione della malattia e sulle complicanze
- attivare servizi alla persona: SAD, ADI, IFeC, UCpDOM
- revisionare la terapia
- discutere **priorità e obiettivi della persona**
- ...

Attività finale

Attività finale

In gruppo

1. Che cosa rende diverse queste due persone?
2. Chi vi sembra più fragile? **Perché?**
3. Quali altre informazioni vorreste conoscere?

Perché valutiamo la fragilità?

La fragilità ci aiuta a riconoscere persone anziane **particolarmente vulnerabili**, nelle quali possono essere presenti **bisogni di salute complessi**.

Riconoscere la fragilità è un punto di partenza, non una conclusione.

Identificare una persona fragile può suggerire la necessità di approfondire la valutazione delle **diverse dimensioni della sua salute**.

Nella prossima lezione: la Valutazione Multidimensionale Geriatrica (VMD).

Che cosa porto a casa?

Verifica finale individuale — 3 minuti

1. Che cosa significa usare il **modello bio-psico-sociale** per comprendere un problema di salute? Spiega anche come interagiscono le sue componenti.
2. Che cosa significa che una persona è **fragile**?
3. Perché esistono **diversi strumenti** per valutare la fragilità? Come sceglieresti quale utilizzare?

Conclusione

Alla prossima!

[se possibile, portate tablet o laptop!] {.alert}

alberto.zucchelli@unibs.it